三、气胸

（一）自发性气胸

可能可能最可能：“ttsx 运功或不运功”突发胸痛、**继之**呼吸困难

肺部本身有基础疾病(COPD、肺结核、肺癌)

气胸 VS 急性肺栓塞

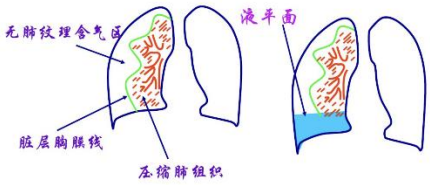
①共性：突发呼吸困难、胸痛、颈静脉怒张 气胸破坏胸腔负压(又吸气又吸血)

②区别：气胸-COPD/肺结核/“运功”等病史，强调顺序（胸痛继之呼吸困难）

肺栓塞-制动等深静脉血栓形成的病史和表现（**不对称**下肢肿痛），**右**心功能不全

（二）气胸的临床表现

1.类似胸腔积液：胸廓**饱满**、肋间隙**增宽**、呼吸音和语音震颤**减弱或消失**、肺下界**移动度减小或消失**、**纵隔（气管/心脏）可向健侧移位**、多无啰音、心尖搏动减弱或消失（左侧大量）、振水音（液气胸）还可见于幽门梗阻

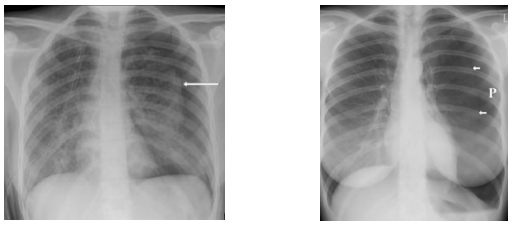


2.**鼓音**，黑曼 Hamman 征（左侧少量气胸或纵隔气肿）

VS 胸膜炎积液量少时可闻及胸膜摩擦音

（三）气胸的辅助检查——X 线

弧形细线外是没有肺纹理的透亮区,线条内是压缩的肺组织



（四）《外科学》中的气胸分类

	别称	破口	胸膜腔内压	ttsx 特点	急救
闭合性	单纯性	已闭合	＜大气压	纵隔可不移位 吸气时健侧胸腔负压更负→把纵隔吸过来	压缩量＜**20%**观察 否则穿刺抽气
开放性 气体自由进出	**交通**性	**吸吮样**	=大气压	纵隔**扑动**（纵隔在**吸**气时移向**健**侧）开摆	**呼**气末堵破口**变开放** **为闭合**纵隔摆回来再堵
张力性	高压性	**活瓣** 气体只进不出	＞大气压	多有脉速、**纵隔及皮下气肿**	**威胁最大→立即穿刺抽气** 张力性气胸也会导致休克，此时也要立即穿刺抽气

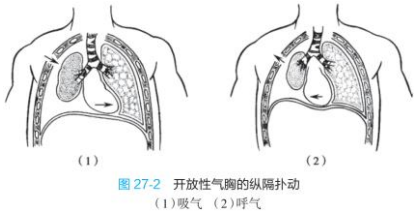
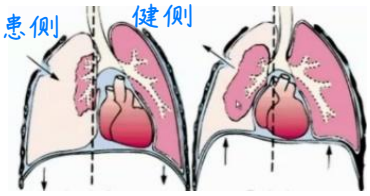
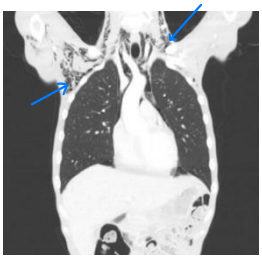


图 27-2 开放性气胸的纵隔扑动
(1)吸气 (2)呼气





eg.高危肺栓塞(就是高危，也休克了)治疗:溶栓



题目中患者有少量的纵隔气肿,但又有开放性气胸的典型特点(吸吮样破口/纵隔摆动),首选考虑开放性气胸(此时是因为外伤导致纵隔/皮下气肿)



张力性气胸:

①吸不了血→回心血量↓前负荷↓搏出量↓→动用心率储备(心率↑)

②胸膜腔压力高→气体可经破裂的肺泡壁进入肺间质(间质性肺气肿)→沿支气管向纵隔扩散→纵隔气肿→蔓延至皮下组织→皮下气肿